DEFINIÇÕES CONFORME MCG HEALTH CARE

- ESTADO MENTAL ALTERADA

Alteração do estado mental (ou seja, diferente do estado basal), conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2)(3)(4):
- Estado confusional (por exemplo, desorientação, dificuldade em seguir comandos, déficit de atenção)
- Letargia (por exemplo, acordado ou despertável, mas com sonolência; redução da consciência de si mesmo e do ambiente)
- Obnubilação (ou seja, despertável apenas com estímulos fortes, menor interesse pelo ambiente, respostas lentas à estimulação)
- Estupor (ou seja, pode ser despertável, mas o paciente não retorna ao nível basal normal de consciência)
- Coma (ou seja, não despertável)

- INSTABILIDADE HEMODINAMICA

Instabilidade hemodinâmica, conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2)(3)(4)(5)(6):
- Anormalidade dos sinais vitais não corrigida pelo tratamento apropriado, conforme indicado por um ou mais dos seguintes[A]:
- Taquicardia que persiste apesar do tratamento apropriado (por exemplo, tratamento da causa subjacente, apesar da observação)
- Hipotensão que persiste apesar do tratamento apropriado (por exemplo, tratamento da causa subjacente, apesar da observação)
- Hipotensão ortostática que persiste apesar do tratamento apropriado (por exemplo, tratamento da causa subjacente, apesar da observação)
- Hipotensão grave, conforme indicado por TODOS os seguintes:
- Hipotensão
- Hipotensão grave, conforme indicado por um ou mais dos seguintes:
- Lactato de 2,0 mmol/L (18 mg/dL) ou mais secundário à hipotensão (ou seja, hipoperfusão)[B](3)(6)
- Acidose metabólica (pH arterial ou venoso[C] inferior a 7,35) sem outra explicação
- Pressão arterial média pressão[A][D] inferior a 65 mmHg Calculadora de PAM Calculadora de PAM
- Medicação inotrópica ou vasopressora intravenosa necessária para manter a pressão arterial ou perfusão adequadas

- HIPOTENSÃO

Hipotensão, conforme indicado por TODOS os seguintes(1)(2)(3)(4)(5):
- Não é o valor basal do paciente (ex.: adulto saudável com PAS baixa) ou meta terapêutica intencional (ex.: PAS baixa como meta de tratamento em insuficiência cardíaca)
- Pressão arterial baixa, conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes:
- PAS inferior a 90 mmHg em adulto ou criança com 10 anos de idade ou mais[A][B]
- Pressão arterial média[C] inferior a 70 mmHg em adulto ou criança com 10 anos de idade ou mais[A][B]Calculadora de PAM Calculadora de PAM
- Diminuição da pressão arterial média basal de 25% ou mais,[C] com sinais ou sintomas significativos devido à pressão arterial baixa (ex.: pré-síncope, síncope, dor no peito)[A][B]Calculadora de PAM Calculadora de PAM
- PAS inferior à soma de 70 mmHg mais o dobro da idade do paciente em anos em crianças de 1 a 9 anos de idade[A][B]
- PAS inferior a 70 mmHg em lactentes de 1 a 11 meses de idade[A][B]

- BRADICARDIA

Bradicardia[A], conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2)(3):
- Frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por minuto em adultos (com 18 anos ou mais)[B]
- Frequência cardíaca inferior a 55 batimentos por minuto em adolescentes de 13 a 17 anos de idade
- Frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto em crianças ou adolescentes de 6 a 12 anos de idade
- Frequência cardíaca inferior a 65 batimentos por minuto em crianças de 3 a 5 anos de idade

- Frequência cardíaca inferior a 70 batimentos por minuto em crianças de 1 a 2 anos de idade
- Frequência cardíaca inferior a 80 batimentos por minuto em lactentes de 6 a 11 meses de idade
- Frequência cardíaca inferior a 90 batimentos por minuto em lactentes de 3 a 5 meses de idade

- TAQUICARDIA

Taquicardia,[A][B] conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2):
- Frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto em adultos ou crianças com 6 anos de idade ou mais
- Frequência cardíaca superior a 115 batimentos por minuto em crianças de 3 a 5 anos de idade
- Frequência cardíaca superior a 125 batimentos por minuto em crianças de 1 ou 2 anos de idade
- Frequência cardíaca superior a 130 batimentos por minuto em bebês de 6 a 11 meses de idade
- Frequência cardíaca superior a 150 batimentos por minuto em bebês de 3 a 5 meses de idade
- Frequência cardíaca superior a 160 batimentos por minuto em bebês de 1 ou 2 meses de idade

- HIPOTERMIA

Hipotermia indicada por temperatura corporal central (por exemplo, retal) menor ou igual a 95 graus F (35 graus C)

- LESÃO RENAL AGUDA ESTAGIO 2:

Lesão renal aguda (estágio 2) com achados clínicos significativos, conforme indicado por TODOS os seguintes(1)(2)(3):
- Lesão renal aguda[A] (estágio 2), conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes[B]:
- Aumento agudo[A] da creatinina sérica entre 2 e 2,9 vezes o seu valor basal[C] (um aumento de 3 vezes o valor basal qualificaria como lesão renal aguda de estágio 3)
- Diminuição do débito urinário,[D] conforme indicado por TODOS os seguintes:
- Avaliação do débito urinário apropriada (por exemplo, estado volêmico adequado, sem obstrução urinária)
- Débito urinário inferior a 0,5 mL/kg/h por 12 horas
- Achados clínicos significativos, conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes[B]:
- Instabilidade hemodinâmica
- Piora do estado clínico apesar da observação (por exemplo, aumento da creatinina ou débito urinário permanece inferior a 0,5 mL/kg/h)
- Alteração do estado mental
- Arritmias cardíacas de preocupação imediata
- Grave Hipertensão (PAS superior a 180 mmHg ou PAD superior a 120 mmHg em adultos ou superior ao percentil 95 para idade, sexo e altura mais 30 mmHg em pacientes pediátricos)(4)(5)
- Achados respiratórios significativos (p. ex., edema pulmonar) que sejam graves (p. ex., hipoxemia) ou persistam apesar do tratamento de observação
- Anormalidade eletrolítica clinicamente significativa que seja grave (p. ex., hipercalemia com achados graves no ECG)[E] ou persista apesar do tratamento de observação
- Anormalidade metabólica clinicamente significativa (p. ex., acidose metabólica) que seja grave ou persista apesar do tratamento de observação

- LESÃO RENAL AGUDA ESTAGIO 3:

Lesão renal aguda[A] (estágio 3),[B] conforme indicado por um ou mais dos seguintes[C](1)(2)(3):
- Aumento agudo[A] da creatinina sérica para 3 vezes o seu valor basal[D] ou superior
- Aumento agudo[A] da creatinina sérica para pelo menos 1,5 vezes o seu valor basal[D] (aumento de 50%) e creatinina sérica superior a 4 mg/dL (354 micromoles/L)
- Em crianças menores de 18 anos, TFG estimada inferior a 35 mL/min/1,73m2 (0,59 mL/s/1,73m2) e um ou mais dos seguintes:
- Aumento agudo[A] da creatinina sérica para pelo menos 1,5 vezes o seu valor basal[D] (aumento de 50%)
- Nas últimas 48 horas, aumento da creatinina sérica superior a 0,3 mg/dL (26,5 micromoles/L)
- Diminuição do débito urinário,[E] conforme indicado por TODOS os seguintes critérios:
- Avaliação do débito urinário adequada (por exemplo, volume urinário adequado, sem obstrução urinária)
- Oligoanúria, conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes critérios:

- Débito urinário inferior a 0,3 mL/kg/h por 24 horas
- Anúria (débito urinário inferior a 0,1 mL/kg/h) por 12 horas
- Início de terapia de substituição renal necessário(4)

- ARRITMIAS CARDIACAS OU ACHADOS DE PREOCUPAÇÃO IMEDIATA:

Arritmias cardíacas ou achados de preocupação imediata, conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2)(3):
- Ritmos cardíacos inerentemente perigosos ou instáveis, conforme indicado por um ou mais dos seguintes(4)(5)(6):
- Fibrilação ventricular ou parada cardíaca revertida
- Ritmo de escape ventricular
- Taquicardia ventricular sustentada (30 segundos ou mais de ritmo ventricular com frequência superior a 100 batimentos por minuto)
- Taquicardia ventricular não sustentada e um ou mais dos seguintes:
- Suspeita de isquemia cardíaca como causa ou consequência de taquicardia ventricular
- Miocardite aguda
- Defeitos de condução cardíaca instáveis, conforme indicado por um ou mais dos seguintes(5)(7):
- Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo II
- Bloqueio atrioventricular de terceiro grau
- Bloqueio de ramo esquerdo de início recente com suspeita de isquemia miocárdica
- Qualquer ritmo cardíaco e um ou mais dos seguindo(4)(8)(9)(10):
- Monitoramento contínuo de ECG a longo prazo necessário (por exemplo, início de medicamento que requer monitoramento além do cuidado de observação)
- O paciente possui um cardioversor-desfibrilador implantável automático que está disparando repetidamente, apresentando mau funcionamento ou necessitando de ajuste imediato das configurações além do escopo do cuidado de observação.
- Ritmos cardíacos preocupantes devido a um ou mais dos seguintes:
  - Hipotensão
  - Dificuldade respiratória
  - Associação com outros sintomas significativos (por exemplo, síncope)(8)(9)

- ALTERAÇÃO DOS SINAIS VITAIS

Alteração dos sinais vitais, conforme indicado por TODOS os seguintes(1):
- Resultados dos sinais vitais não condizentes com a condição crônica do paciente ou com seus valores basais (ex.: pressão arterial intencionalmente baixa em insuficiência cardíaca)
- Anormalidade dos sinais vitais, conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes:
    - Taquicardia
    - Hipotensão
    - Hipotensão ortostática - Hipotensão ortostática,[A][B] conforme indicado por um ou mais dos seguintes(1)(2)(3):
        - Queda na PAS de 20 mmHg ou mais de 1 a 3 minutos após o paciente sentar ou levantar-se da posição deitada
        - Queda na PAD de 10 mmHg ou mais de 1 a 3 minutos após o paciente sentar-se ou levantar-se da posição deitada

- TAQUIPNEIA

Taquipneia,[A][B] conforme indicado por uma frequência respiratória de 1 ou mais dos seguintes(2)(3):
- Superior a 18 respirações por minuto em adulto ou criança com 13 anos de idade ou mais[A]
- Superior a 22 respirações por minuto em criança de 6 a 12 anos de idade[A]
- Superior a 25 respirações por minuto em criança de 3 a 5 anos de idade[A]
- Superior a 30 respirações por minuto em criança de 1 ou 2 anos de idade[A]
- Superior a 40 respirações por minuto em lactente de 6 a 11 meses de idade[A]
- Superior a 45 respirações por minuto em lactente de 3 a 5 meses de idade[A]
- Superior a 60 respirações por minuto em lactente de 1 ou 2 meses de idade[A]

- DIFICULDADE RESPIRATORIA

Dificuldade respiratória, conforme indicado por TODOS os seguintes(1)(2):

- Paciente com 1 ou mais dos seguintes:
    - Dispneia (dificuldade para respirar)
    - Taquipneia
    - Padrão respiratório anormal (ex.: retrações torácicas)
    - Outras evidências de dificuldade para respirar
    - Evidências de comprometimento respiratório, conforme indicado por 1 ou mais dos seguintes:
    - Hipoxemia
    - Alteração do estado mental
    - Outras evidências de comprometimento respiratório (ex.: acidose respiratória)

- HIPOXEMIA

Hipoxemia, conforme indicado por um ou mais dos seguintes critérios(1):
- Paciente sem necessidade basal de oxigênio suplementar com saturação de oxigênio (SpO2) inferior a 90% ou pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2) inferior a 60 mmHg (8,0 kPa) em ar ambiente[A][B]
- Paciente sem necessidade basal de oxigênio suplementar que agora necessita de oxigênio suplementar para manter SpO2 superior a 89% ou PaO2 superior a 59 mmHg (7,9 kPa)[A]
- Paciente com necessidade basal de oxigênio suplementar que agora necessita de aumento da dose de oxigênio suplementar para manter a oxigenação no nível basal ou em um nível aceitável

Enviar feedback

- ACHADOS RESPIRATORIOS GRAVES

Achados respiratórios graves (não responsivos à observação e cuidados adequados), incluindo um ou mais dos seguintes(1)(2)(3):
- Dificuldade respiratória, conforme indicado por TODOS os seguintes(2)(4):
    - Paciente com um ou mais dos seguintes:
    -Dispneia (dificuldade para respirar)
    -Taquipneia
    -Padrão respiratório anormal (por exemplo, retrações torácicas)
    -Outras evidências de dificuldade para respirar
- Evidências de comprometimento respiratório, conforme indicado por um ou mais dos seguintes:
    -Hipoxemia
    -Alteração do estado mental
    -Outras evidências de comprometimento respiratório (por exemplo, acidose respiratória)
- Hemoptise macroscópica[A](5)(6)
- Cianose aguda

- SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO FISICO D SOCIEDADE AMERICANA DE ANESTESIOLOGISTAS (ASA)

Sistema de Classificação do Estado Físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)[A](2)(3)(4)(5)(6)(7)
- Classe I: Paciente normal e saudável
- Classe II: Paciente com doença sistêmica leve
- Classe III: Paciente com doença sistêmica grave
- Classe IV: Paciente com doença sistêmica grave que representa ameaça constante à vida
- Classe V: Paciente moribundo que não tem expectativa de sobreviver sem a cirurgia